



结核病

2026年3月24日 | 阅读时间 12 分钟 (3179 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

重要事实

- 2024年总共有123万人死于结核病（其中包括15万名艾滋病毒感染者）。全球范围内，结核病是单一传染病原体导致的全球主要死因，是全球十大死因之一。
- 2024年，结核病还是艾滋病毒感染者的头号杀手，以及导致抗微生物药物耐药性相关死亡的一个主要原因。
- 2024年，全球估计有1070万人罹患结核病，其中包括580万名男性、370万名女性和120万名儿童。所有国家和所有年龄组都有结核病感染。
- 耐多药结核病仍然是一项公共卫生危机和卫生安全威胁。2024年，只有约五分之二耐药结核病患者获得治疗。
- 自2000年以来，全球抗击结核病努力已拯救约8300万人的生命。
- 结核病是可以预防和治愈的。

概述

结核病是一种由细菌引起的传染病，大多影响肺部。结核病可在其患者咳嗽、打喷嚏或吐痰时通过空气传播。

结核病是可以预防和治愈的。

据估计，全球约四分之一的人口感染结核杆菌。一般而言，感染结核杆菌的人不会感到不适，也不会传染。大约5%至10%的感染者最终会出现症状并发展为结核病。婴儿和儿童如果感染，患病风险较高。

结核病通常使用抗生素进行治疗，如果不治疗，可能会致命。

在某些国家，为婴幼儿接种抗结核疫苗（卡介苗）以预防结核病。该疫苗可以防止结核病导致的死亡，并保护儿童免受严重结核病的侵害。

某些情况会增加一个人患结核病的风险：

- 糖尿病（高血糖）；
- 免疫系统减弱（例如因受艾滋病毒影响）；
- 营养不足；
- 烟草使用；以及
- 有害使用酒精。

症状

一般而言，感染结核杆菌的人不会感到不适，也不会传染。只有一小部分感染者会发展为结核病和出现症状。婴儿和儿童如果感染，患病风险较高。

当细菌在体内繁殖并影响多种器官时，就会发生结核病。结核病的症状可能以轻微形式持续数月，因此，很容易在不知情的情况下将结核病传给他人。症状取决于受到结核病影响的身体部位。结核病通常影响肺部，但它也会影响肾脏、大脑和脊柱。

有些结核病患者没有任何症状，但仍可能会传播此病毒。

结核病的常见症状有：

- 长期咳嗽（有时带血）；
- 胸痛；
- 虚弱无力；
- 疲劳；
- 体重减轻；
- 发热；
- 盗汗。

人们出现的症状取决于受到结核病影响的身体部位。结核病通常影响肺部，但也可能影响肾脏、大脑、脊柱和皮肤。

预防

请按照以下步骤帮助预防结核病感染和传播：

- 如果有长期咳嗽、发烧和不明原因的体重减少等症状，请就医，因为结核病的及早治疗可有助于阻止疾病传播并增加康复机会。
- 如果自己面临的风险升高，例如感染了艾滋病毒或与家里或工作场所中的结核病患者有接触，请进行结核病检测。
- 预防性抗结核治疗可防止感染变成疾病。如果按处方进行预防性抗结核治疗，则要完成整个疗程。
- 如果患有结核病，咳嗽时请保持良好的卫生习惯，包括避免与他人接触并佩戴口罩，咳嗽或打喷嚏时遮住口鼻，以及正确处理痰液和用过的纸巾。
- 采取使用呼吸器和良好通风等特殊措施对于减少卫生保健设施和其他机构内的感染非常重要。

诊断

世卫组织建议使用快速诊断检测工具作为所有有结核病体征和症状者的初始诊断检测方法。

世卫组织推荐的快速诊断检测包括在医疗服务点对生物标志物进行检测和分子检测。所有这些检测均很准确，能在采样后48小时内提供初步结果，用于指导治疗决定。进行这些检测将有助于在早期发现结核病和耐药结核病方面取得重大进展。

诊断耐药结核病（包括耐多药结核病）以及与艾滋病毒相关的结核病和儿童结核病可能很复杂。世卫组织建议使用特定的样本类型、检测方法和策略来检测这些结核病，以提高早期准确发现疾病的可能性。

可采用结核菌素皮肤试验(TST)、干扰菌瘤释放试验(IGRA)或较新的基于抗原的皮肤试验(TBST)识别感染者。可根据这些结核病感染检测结果确定哪些高风险结核病患者最能从结核病预防治疗中受益。

治疗

可使用专门抗生素治疗结核病。建议对结核菌感染和结核病都进行治疗。

最常用的抗生素是：

- 利福平；
- 异烟肼；
- 吡嗪酰胺；
- 乙胺丁醇片。

要想有效治疗，需在4-6个月中每天服用药物。过早停药或在没有医生建议的情况下停药是危险的，因为这会促使体内的结核杆菌对抗生素产生耐药性。

对标准药物没有反应的结核病被称为耐药结核病，需要使用不同的药物进行治疗。

耐多药结核病

当抗结核药物由于医务人员处方不当、药品质量低劣或患者过早中断治疗而得不到正确使用时，便会出现耐药性。

耐多药结核病是一种由对异烟肼和利福平这两种最有效的一线抗结核药物均无反应的细菌导致的结核病。耐多药结核病可以通过使用其他药物得到治疗和治愈，但这些药物往往较昂贵且副作用较多。暴露于耐多药结核病的患者可能会接受左旋氟沙星的结核预防治疗。

在某些情况下，可能会出现广泛耐药结核病。由对耐多药结核病治疗方案中最有效的药物没有反应的细菌引起的结核病会使患者的治疗选择非常有限。

耐多药结核病仍是公共卫生危机。2024年，只有约五分之二耐多药结核病患者获得治疗。

根据世卫组织指南，为发现耐多药结核病，需要对结核病进行细菌学确认，并使用快速分子检测或培养方法进行耐药性检测。

2022年，新的世卫组织指南将6个月短程全口服治疗方案（BPaLM/BPaL）作为符合条件患者的首选治疗方法。2024年，全球约有34000名耐多药或对利福平耐药结核病患者开始接受为期6个月的短程治疗方案（BPaLM和BDLLfxC）治疗，治疗人数大幅高于2023年的5653人和2022年的1744人。这种新的治疗方案疗程更短，药丸负担更低，疗效高，有助于降低卫生系统的负担，节省宝贵的资源，从而进一步扩大覆盖范围，为所有有需要者提供诊断和治疗。世卫组织建议扩大提供全口服治疗方案。

结核病和艾滋病毒

艾滋病毒感染者罹患结核病的可能性是未感染艾滋病毒者的12倍。结核病是导致艾滋病毒感染者死亡的首要原因。

艾滋病毒和结核病的并存具有致命性，它们会相互加剧病情。2024年，约有15万人死于与艾滋病毒相伴的结核病。2024年，有艾滋病毒检测结果记录的结核病患者比例为82%。这一比例略高于2023年的81%。世卫组织非洲区域的艾滋病毒相关结核病负担最重。2024年，在全球范围内，只有61%的患结核病的艾滋病毒感染者接受了抗逆转录病毒治疗。

世卫组织于2004年首次建议开展联合抗击结核病/艾滋病活动，以降低艾滋病毒相关结核病的发病率和死亡率。这些活动包括双向筛查、预防、治疗感染和疾病。据估计，由于扩大了结核病治疗和抗逆转录病毒治疗，自2005年以来，已避免了980万人死亡。

影响

结核病主要影响年富力强的成年人。但是，所有年龄组人群均面临风险。超过80%的病例和死亡发生在低收入和中等收入国家。

世界各地都有结核病感染发生。2024年，世卫组织东南亚区域的结核病新发病例数量最多（占34%），其次是西太平洋区域（占27%）和非洲区域（占25%）。约87%的新发结核病病例发生在30个结核病负担沉重的国家，其中全球总数的三分之二分布在印度（25%）、印度尼西亚（10%）、菲律宾（6.8%）、中国（6.5%）、巴基斯坦（6.3%）、尼日利亚（4.8%）、刚果民主共和国（3.9%）和孟加拉国（3.6%）。前五个国家占全球总数的55%。

在全球范围内，约50%接受结核病治疗的患者及其家庭面临的总费用（直接医疗支出、非医疗支出和收入损失等间接费用）具有灾难性（高于家庭总收入的20%），远未达到世卫组织《终止结核病战略》确立的零目标。免疫系统受损人群，如艾滋病毒感染者、营养不良者或糖尿病患者，或使用

烟草者，面临较高的患病风险。2024年，全球估计有97万例结核病新发病例可归因于营养不良，93万例可归因于糖尿病，74万例可归因于酒精使用障碍，70万例可归因于吸烟，57万例可归因于艾滋病毒感染。

为终止结核病进行投资

为实现2023年联合国结核病问题高级别会议商定的2027年全球目标，每年需要提供220亿美元用于结核病预防、诊断、治疗和护理。

与过去十年一样，2024年结核病服务的大部分支出资金（82%）来自国内。按绝对数字计算，在低收入和中等收入国家国内支出48亿美元总额中，巴西、中国、印度、俄罗斯联邦和南非支出额为31亿美元（占64%）。国际捐款总额为11亿美元。自2015年以来，国际捐款总额几乎每年都在11亿美元至12亿美元之间波动。2023年用于结核病研究和创新的资金为12亿美元，仍远低于每年50亿美元的全球目标。受整体投资水平影响，目前进展受限。

世卫组织的应对

世卫组织正在与各国、合作伙伴和民间社会密切合作，扩大结核病应对工作。世卫组织履行其六项核心职能，以促进实现2023年联合国高级别会议政治宣言、可持续发展目标、《世卫组织终止结核病战略》和世卫组织战略重点的各项目标。